Etica

MC ANNO 2026/2027

COS'È L'ETICA

Scienza che prova a rispondere alla domanda *"cosa è giusto e cosa è sbagliato?"* Chiaramente non esiste una risposta oggettiva e assoluta → ci basiamo su diverse correnti e teorie

L'**etica** si rifà e deriva molto dalla **filosofia**: possiamo usare etica e **filosofia morale** in maniera intercambiabile

> L'etica è *la riflessione critica e razionale su ciò che è giusto e sbagliato, sui principi, sui valori e sulle norme di una determinata società o individuo*
>
> In breve: la filosofia/etica applicata ci serve come aiuto ad analizzare e risolvere problemi pratici (problemi etici)

Problemi etici / morali

Esempi in ambito sanitario:

- **Eutanasia** (in Svizzera: qualsiasi gesto eseguito dai curanti che non è volto alla guarigione, ma che aiuta il paziente a morire)
- **Suicidio assistito**: è la persona stessa a compiere il gesto (Exit e simili: associazioni private senza scopo di lucro, per il bene del paziente)
- **Eutanasia attiva**: il medico/infermiere esegue un'iniezione letale (in CH illegale; legale in Belgio, Olanda, Canada, ...)
- **Rianimazione** (REA o NO REA): si ragiona sulla qualità di vita del paziente dopo la rianimazione
- **Segreto professionale**: quando mantenerlo e quando no

- **Aborto**

Esempi più in generale: pena di morte, etica dell'IA, "esiste una guerra giusta?" (→ leva obbligatoria e obiezione di coscienza)

⇒ La risposta a questi temi cambia col punto di vista della società. Il ruolo dell'etica non è dare risposte assolute, ma analizzare i vari punti di vista e le varie correnti di pensiero

Obiettivi e programma del corso

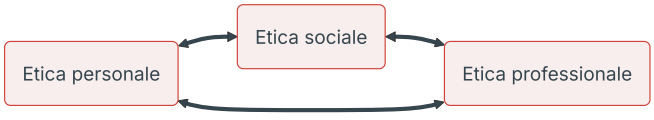
Obiettivo principale: acquisire le basi per lo studio futuro dell'etica in ambito sanitario

- conoscere principi, valori e norme alla base della società e delle professioni sanitarie
- saper analizzare casi pratici con concetti, teorie e modelli etici
- saper argomentare il proprio punto di vista su questioni professionali

Programma: **introduzione** (etica personale/sociale/professionale) → **teorie etiche** (deontologica, delle conseguenze, della cura) → **bioetica** (aborto, fecondazione assistita, eutanasia; sacralità vs qualità della vita)

> Come linee guida nazionali: Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (**ASSM**)

ETICA PERSONALE, SOCIALE E PROFESSIONALE

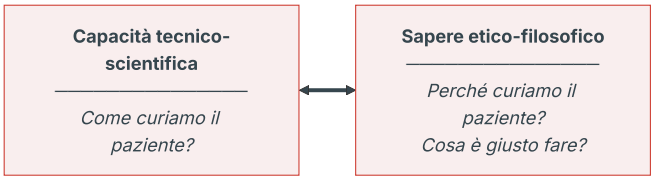


- **Etica personale**: cosa è giusto o sbagliato per me (i miei principi e valori)
- **Etica sociale**: cosa è giusto o sbagliato per la società → la **morale sociale**: l'insieme di principi, valori e norme di una società

    - Norme scritte → le leggi (non uccidere, non rubare, non fare violenza)
    - Norme non scritte → abitudini e consuetudini sociali
    - La morale limita la libertà degli individui per garantire l'**ordine sociale** → lo scopo è la sopravvivenza della società (pace/sicurezza sociale)
- **Etica professionale**: cosa è giusto o sbagliato nella mia professione (principi, valori e norme della professione)

I tre livelli interagiscono e si influenzano. Quando etica personale ed etica professionale entrano in conflitto si parla di **obiezione di coscienza** → che si interfaccia spesso col principio di **non discriminazione** (es: non assumere un'infermiera cattolica perché contraria all'aborto = discriminazione)

Nell'etica professionale c'è una differenza tra i due saperi, che si completano a vicenda:



Caso: interruzione di gravidanza

> Una ragazza di 20 anni, studentessa, scopre di essere incinta alla sesta settimana. Col ragazzo (22, studente, relazione da tre mesi) hanno sempre usato le precauzioni, ma qualcosa è andato storto. Non sa se abortire o no e si rivolge a un OS per una consulenza.

- **Etica personale** → il ragionamento che farà la ragazza per la propria salute e il proprio futuro
- **Etica sociale** → l'aborto è permesso per legge in Svizzera, quindi l'etica sociale lo permette
- **Etica professionale** → richiede oggettività: l'OS deve solo permettere alla ragazza di fare

una scelta informata (non può scegliere per lei). La libertà di scelta del paziente è un diritto

Concetti chiave che escono dal caso:

- **Principio di autonomia / autodeterminazione** → capacità del paziente di riflettere e decidere cosa è giusto per sé
- Per restare oggettivi in etica: dare ragioni a favore e contro → assicurare imparzialità
- **Consenso libero e informato**: il paziente firma sempre → indica l'oggettività della consulenza e la libera scelta (si prende la sua responsabilità individuale)

Analisi di casi pratici

Schema in 5 passi usato in classe:

1. Individua il problema etico
2. Giudizio individuale immediato
3. Giustifica il giudizio
4. Confronta la propria posizione con gli altri
5. Prova a trovare una soluzione condivisa (valutando gli altri punti di vista)

La sonda alimentare

> In casa anziani, paziente con demenza in fase avanzata non mangia più. Sarebbe necessario un sondino PEG per la nutrizione artificiale. Non tutti i curanti sono d'accordo.

- *Sapere tecnico-scientifico*: come funziona una sonda PEG? Quali sono i rischi?
- *Sapere etico-filosofico*: è giusto nutrire artificialmente? È ciò che vorrebbe il paziente?

Anna e Monica

> Anna è in stage in chirurgia. Le norme igieniche sono particolarmente severe per i pazienti MRSA positivi, che devono restare in isolamento. Anna si stupisce quando scopre che a Monica —

> appena amputata di un alluce per una ferita infetta — è concesso, rispettando le precauzioni (disinfezione mani, camice pulito, ferita bendata), di passeggiare nel reparto. Il "privilegio" serve a evitare che l'isolamento aggravi la depressione di cui Monica soffre.

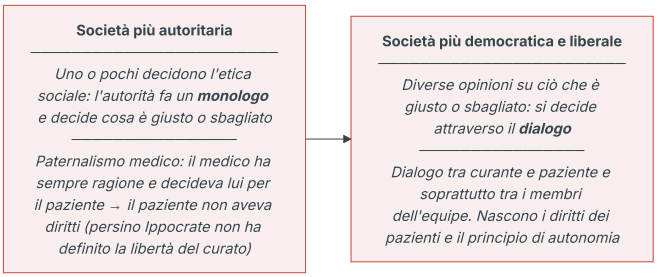
1. **Problema etico**: contrapposizione tra isolamento per prevenire contagi (indiretti) e isolamento come aggravante della depressione (già presente)
2. **Giudizio immediato**: prima di concedere il privilegio sono state applicate diverse misure preventive, perciò è lecito lasciar passeggiare Monica
3. **Giustificazione**: quando ci prendiamo a carico il paziente non prendiamo a carico solo la malattia (l'alluce infetto), ma tutta la persona. Data la correlazione tra salute fisica e mentale, date le precauzioni prese, è corretto permettere a Monica di passeggiare: un piccolo gesto per noi che aiuta molto la paziente

Gli altri casi visti in classe

- **Chiara e Camilla**: in casa anziani gli ospiti vengono legati alla sedia durante i pasti per evitare cadute; Camilla (82, instabile sulle gambe ma lucida) chiede di essere "liberata dal guinzaglio" → contenzione/sicurezza vs libertà e dignità della persona
- **Marco e Renzo**: Renzo ha un tumore al pancreas in stadio avanzato ma non conosce la diagnosi (i figli hanno chiesto di non dirgliela); chiede a Marco "Ce la farò, vero?" → verità al paziente e autonomia vs protezione dal dolore
- **Piero e Sara**: Sara (sclerosi multipla + anoressia) rifiuta spesso il cibo; a Piero viene chiesto di collaborare a una somministrazione contro la sua volontà → beneficenza vs autodeterminazione

TEORIE ETICHE

Una **teoria etica** è un modello di pensiero che ci può dire cosa è giusto o sbagliato, e come comportarci, in determinati casi, a partire da un certo punto di vista

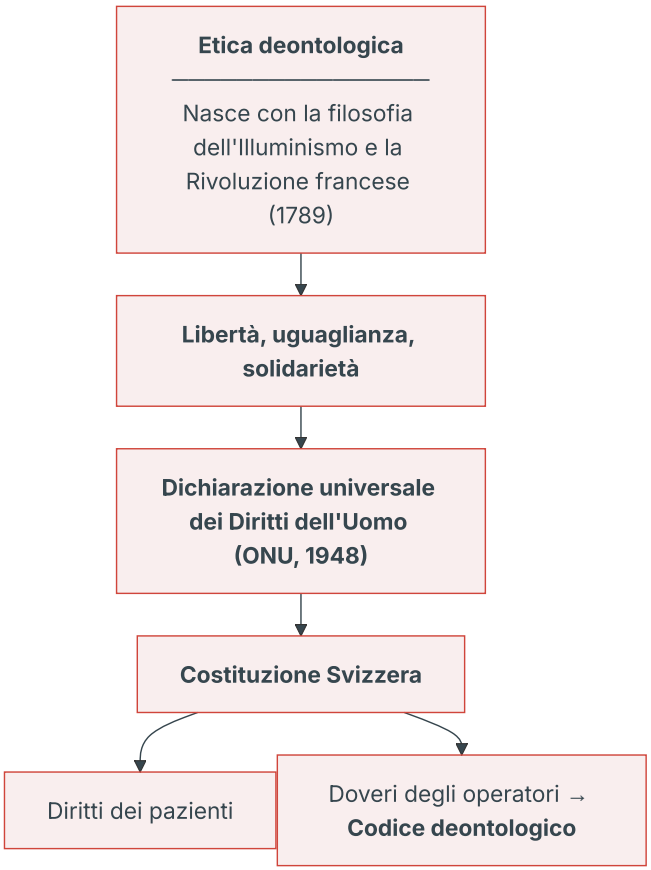


Le tre teorie del corso: **Etica Deontologica** · **Etica delle Conseguenze** · **Etica della Cura**

Etica deontologica

Dal greco *Deon* → **dovere**. Logica di base: i miei diritti sono rispettati dai doveri altrui, e viceversa → voglio che i diritti valgano per tutti, così ho la garanzia che valgano anche per me (e si evitano abusi di potere)

Genealogia — da dove arriva:



Diritti e doveri — due facce dell'uguaglianza dei diritti fondamentali:

- **Diritti**: alla vita, libertà di parola, espressione, credenza → per i curati: diritto alla cura e alla salute in quanto persona
- **Doveri**: non uccidere, rispettare, tollerare → per i curanti: dovere di curare tutti i pazienti, secondo **uguaglianza** e **non discriminazione**
  - *Vogliamo vivere in una società dove gli operatori sanitari scelgono chi curare e chi no?* → nessuno può decidere chi può essere curato e chi no

Principi chiave:

- I principi sono assoluti: vanno rispettati sempre, indipendentemente dalle conseguenze → rispetto ai principi assoluti, il fine non giustifica mai i mezzi
- **Ultima ratio**: una misura che va contro un diritto fondamentale è ammessa solo come

ultimissima risorsa (es. contenzione, trattamento senza consenso, violazione del segreto professionale → solo in casi eccezionali)

- **Criterio di proporzionalità**: la misura che va contro il diritto deve essere la meno invasiva possibile
- Principi ideali (obiettivi a cui tendere): **integrità fisica** (non fare violenza fisica) e **integrità psichica** (non fare violenza psichica)

Estratto della Costituzione Svizzera (capitolo "Diritti fondamentali") — gli articoli chiave:

- Art. 7 — la dignità umana va rispettata e protetta
- Art. 8 — uguaglianza giuridica: nessuno può essere discriminato (origine, sesso, età, lingua, posizione sociale, convinzioni, disabilità, ...)
- Art. 10 — diritto alla vita (pena di morte vietata) e alla libertà personale (integrità fisica e psichica); tortura vietata
- Art. 11 — protezione di fanciulli e adolescenti
- Art. 12 — diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (esistenza dignitosa)
- Art. 13 — protezione della sfera privata
- Art. 15 — libertà di credo e coscienza

Etica deontologica ed etica professionale: sta a fondamento dei **diritti dei pazienti** e del **codice deontologico** — regole, norme e doveri che l'operatore deve sempre seguire:

- dovere di curare ogni paziente in quanto persona
- parità di trattamento e non discriminazione
- rispetto della libertà di scelta informata e dell'autonomia (se il paziente non è capace di discernimento: rappresentante legale e **volontà presunta**)

I codici deontologici (cure infermieristiche, ergoterapia, fisioterapia): principi comuni → rispetto della persona, della sua **autonomia** e **dignità**; informazione comprensibile e **consenso**; promozione/mantenimento dell'autonomia del paziente; **segreto professionale** e protezione dei dati

Etica delle conseguenze

(in corso a lezione — da integrare con quanto diremo in classe)

A differenza della deontologica, non ci sono principi, valori o norme assolute da rispettare sempre: ciò che conta sono le **conseguenze delle azioni**

- Un'azione è giusta o sbagliata in base ai suoi effetti positivi e negativi sulle persone coinvolte → vanno valutati, calcolati e **bilanciati**
- In questa filosofia il fine può giustificare i mezzi (nella deontologica mai)

Utilitarismo

La principale etica delle conseguenze (**J. Bentham e J.S. Mill**):

- si stabilisce cosa è bene per tutti, un valore condiviso: il piacere, il benessere, la felicità (a seconda delle versioni)
- azione **giusta** = produce più piacere/benessere/felicità per la maggioranza delle persone coinvolte
- azione **sbagliata** = produce più dispiacere/malessere/sofferenza (o fa il bene solo mio a scapito degli altri)

> *"...più le persone intorno a me stanno bene, sono felici, più starò bene anche io..."* → se non riusciamo a fare il bene di tutti, almeno della maggioranza

Esempi di ragionamento consequenzialista:

- **Uccidere?** Di norma no (sofferenza per la persona, i cari, la società; "bene" solo per l'assassino) — ma uccidere un tiranno può essere lecito se migliora il benessere di un popolo (es. discussioni su Saddam Hussein, Bin Laden) → valutando sempre *tutte* le conseguenze
- **Rubare?** Di norma no — ma rubare 1 miliardo a Jeff Bezos per darlo in beneficenza? Per il consequenzialismo può essere giusto; per la deontologica solo come *ultima ratio*. Rischio: se tutti rubassero ai ricchi → caos e abusi
- **Mentire?** "Cristina vuole uccidere Maria e ti chiede dove si trova": per le conseguenze, mentire qui è giusto
- **Responsabilità e intenzione**: investire un pedone non visto a 50 km/h → distinzione tra doloso (intenzionale) e colposo (non intenzionale)

Applicazione all'etica professionale

Riferimento alla definizione di salute dell'**OMS (1948)**: *"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia"*

- scopo dell'operatore: **fare il bene** (promuovere benessere e salute) e **contrastare il male** (malessere e malattia), del singolo e di tutti i pazienti di cui è responsabile
- da valutare: costi/benefici, maleficenza/beneficenza, per il singolo e per la collettività

Deontologica + Conseguenze insieme

Etica deontologica	Etica delle conseguenze
Diritti e doveri fondamentali	Fare il bene: benessere, salute

Etica deontologica	Etica delle conseguenze
Principi assoluti	Contrastare il male: malessere, malattia
Ultima ratio, proporzionalità	Valutare e calcolare le conseguenze
Diritti dei pazienti, codice deontologico	Azione giusta = + benessere, + salute
Libertà, autonomia, uguaglianza, dignità, integrità	Per tutti o per la maggioranza
Il fine non giustifica mai i mezzi	Il fine può giustificare i mezzi
Responsabili di rispettare i principi	Responsabili delle conseguenze delle azioni

> Nella maggioranza dei casi vanno applicate insieme: rispettare i principi primi e i diritti dei pazienti, *e* valutare le conseguenze in termini di benessere/malessere per paziente e collettività

Etica della cura

"Cura" ha più significati: sollecitudine, dedizione, attenzione, assistenza / terapia per guarire una malattia. Qui si intende il prendersi cura degli altri (e di sé)

> In inglese: **cure** (curare, terapia medica) vs **care** (prendersi cura, dedicarsi a qualcuno)

È un'etica della vita e delle relazioni, che può essere anche etica professionale. Riferimenti: **C. Gilligan** (*Con voce di donna*, 1982), esistenzialismo e fenomenologia (Heidegger, E. Stein)

I fondamenti:

1. **Una "voce femminile" dell'etica**: storicamente la cura è stata compiuta dalle donne (madri,

infermiere) nel privato, mentre gli uomini dibattevano nel pubblico → risposta alle relazioni uniche e individuali dimenticate dalle "etiche maschili" (deontologica e conseguenze)

2. **L'essere umano è fragile**: più di ogni altra specie necessita della cura degli altri per sopravvivere, dalla nascita in poi — e può sempre ricadere nella dipendenza (incidenti, malattie, invecchiamento)
3. **Esistere = essere in relazione**: diventiamo qualcuno a partire da relazioni di dipendenza, educazione e cura → siamo tutti potenzialmente a rischio di avere bisogno di cure: ci si aiuta per solidarietà *e perché un giorno toccherà anche a me*
4. **Comprensione empatica**: capire il vissuto e i bisogni dell'altro proiettandosi in lui (come la madre col bambino che piange) → l'empatia permette di capire anche chi non riesce a esprimersi a parole
5. **Cura autentica vs inautentica**:
   - inautentica → "assistenzialista"/"maternalista": rende l'altro dipendente da me (non taglia il cordone ombelicale)
   - autentica → parte dalla dipendenza ma ha come scopo l'**autonomia**: *"curare affinché l'altro sappia prendersi cura di sé"*

> **N.B.**: l'etica della cura non ci dice cosa è giusto o sbagliato fare, ma cosa bisognerebbe fare sempre e prima di tutto: assistenza, dedizione, relazione, ascolto, empatia, comprensione dei bisogni

Schema di analisi di un problema morale

1. Comprendere i vari punti di vista delle persone coinvolte
2. Analizzare **pro e contro** applicando le teorie:

PROBLEMA MORALE: ...	PRO	CONTRO
Etica deontologica		
Etica delle conseguenze		

con l'**etica della cura** come base di partenza (ascolto, empatia, bisogni)

1. Trovare la soluzione migliore e più giusta

Esempi di problemi da analizzare: "è giusto vietare il fumo?", "è giusto imporre le vaccinazioni?", "è giusto donare gli organi?"

BIOETICA

(ancora da trattare a lezione: aborto, fecondazione assistita, eutanasia; etica della Sacralità della Vita vs etica della Qualità della Vita)